

【소속, 성명】 : ☆ 부, 과장 BU

【제 목】 : 민간병원 특성을 반영한 신포괄수가제도 모형 개선

【내 용】

□ 추진배경

- 신포괄지불제도는 국민건강보험공단일산병원 입원환자를 대상으로 '09년 4월부터 시범사업을 시작하여 42개 공공기관을 중심으로 운영
- 2018년 8월 민간병원 확대 후 '20년 현재 민간기관을 포함한 98개 기관에서 시범사업을 운영하고 있음
- 이에 공공병원 중심으로 설계된 신포괄수가 모형을 민간병원의 다양한 특성을 반영한 모형으로 개선하고 견고한 기반 마련에 대한 필요성이 대두됨

□ 추진내용

- 「정책가산조정방안(신현웅, 한국보건사회연구원, 2016)」
- 신포괄수가제 모형개선 중장기('19~'23년) 로드맵(1단계)에 의한 모형 및 제도 개선
- 2018. 8월 신규참여 기관, 2019. 1월 기존기관 포함 64개 기관에 모형 개선된 정책가산 적용

□ 추진성과

- 정책가산은 시범사업 도입 때부터 적용하기 시작하여 가산항목과 가산비율 점진적으로 증가
 - ('09.4.) 5% → ('14.1.) 최대 15% → ('15.4.) 최대 35%
- 2018. 8. 1. 적용 가산비율
 - 공공병원 최대 35%적용

- 민간병원 최대 30%+ α (경영성과지표 5% 제외, 비급여(α) 2% 지급)

구분	비율(최대)	지표 차이
공공병원	35%	경영성과 5% 적용
민간병원	30%+ α (2%)	비급여 축소분 보상(α)

○ 신포괄수가제 시범사업 대상기관 확대

구분	대상기관	비고
공공병원	42개소	기존기관
민간병원 1차	14개소	2018.8. 참여
민간병원 2차	8개소	2019.1. 참여
민간병원 3차	4개소	2019.8. 참여
민간병원 4차	30개소	2020.1. 참여

○ 정책가산 개선현황

- 신포괄수가제 도입 취지에 부합하고 민간병원에도 적용 가능한 지표개발
- 단순 참여가산, 공공성취약계층 진료서비스 축소
- 자료제공, 의료의 질 및 비급여 관리 신설

구분	기존(35%)	
	항목	가산율
참여	일괄부여	5%
효율성	경영성과	5%
효과성	간호등급	2%
	간호·간병 통합서비스	3%
	신포괄정보관리	5%
공공성	의료급여 진료	5%
	차상위계층 진료	3%
	취약지	1%
	필수진료시설운영	5%
	감염병관리	1%
의료의 질	-	-
비급여 관리	-	-



개선방향(35%)	
항목	가산율
일괄부여	3%
자료의 제공	2%
자료의 질	1%
경영성과	5%
간호등급	2%
간호·간병 통합서비스	3%
신포괄정보관리	5%
의료급여+차상위계층	4%
취약지	1%
필수진료시설운영	3%
감염병관리	1%
재입원비	1%
외래방문 횟수비	1%
비급여 비중	2%
비급여 개선도	1%
추가지표(α)	+ α

□ 향후 추진계획

- 전문병원 등 다양한 참여기관의 확대와 「신포괄 모형개선 및 의료 질 관리방안」 연구('19.2.~'20.1.) 결과를 바탕으로 개선(안) 마련
 - 시급성, 시범사업 확대 계획 등을 고려하여 단계적 추진
- 단기 개선방향(안)
 - 적용시기 고려, 가산 규모는 현행수준 유지(최대 35~32%)하되 의료 질 향상 등을 반영한 지표개발 및 평가기준 강화
 - 의료기관 인증평가 여부 신설 등 의료의 질 지표 확대, 비급여 관리 지표 개선, 정보관리 축소 등
- 중장기 개선방향(안)
 - 의료이용 형평성 제고(접근성, 필수의료), 의료비 관리 강화 등을 위한 세부지표 개발
 - 비용(원가)기반 신포괄수가 개발과 연계하여 관련 인센티브 재 정비, 정책가산 규모 단계별(5년간) 축소 방안 검토(35%→25%)